БОНУС 2

50-те грешки в описанието, които ръководителят поправя най-често

50 грешки, заради които описанията се връщат; всяка в реда „Написано → Правилно → Защо“. Поправете собственото си описание, преди да се сблъскате с червената химикалка на Вашия ръководител.

Съдържание

Как да използвате този списък

Техника и сравнение — 6 грешки

Терминология — 7 грешки

Локализация, страна и размер — 8 грешки

Находки — 9 грешки

Заключение — 8 грешки

Препоръка — 4 грешки

Спешна находка и съобщаване — 4 грешки

Форма и преди подписване — 4 грешки

Следваща стъпка

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Как да използвате този списък

Грешките са групирани по метода от 4 стъпки: ПОДГОТВЕТЕ, ПРЕГЛЕДАЙТЕ, ОПИШЕТЕ, ОБОБЩЕТЕ.

> *Повечето грешки в описанията не произтичат от липса на знания, а от навик. А навикът се поправя, щом веднъж бъде забелязан.*

СТЪПКА ОТ МЕТОДА	СВЪРЗАНИ ГРУПИ ГРЕШКИ
ПОДГОТВЕТЕ	Техника и сравнение
ПРЕГЛЕДАЙТЕ	Находки (пропуски и важни отрицателни находки)
ОПИШЕТЕ	Терминология · Локализация, страна и размер · Находки
ОБОБЩЕТЕ	Заключение · Препоръка · Спешна находка и съобщаване · Форма и преди подписване

1. **В продължение на една седмица четете по една група всеки ден.** Осем групи, осем дни.
2. **Съпоставяйте всяко описание, коригирано от Вашия ръководител, с този списък.** Ако една и съща грешка се повтори два пъти, добавете я в контролния си списък.
3. **Преди подписване приложете Контролния списък на описанието на една страница.** Точките в списъка са обобщение на тези 50 грешки.

Практика на институцията

Ако форматът на описанието или терминологичните предпочитания във Вашето отделение се различават от примерите тук, важи правилото на отделението. Основната цел е да усвоите принципа: ясно, премерено, сравнително описание, което отговаря на въпроса.

ГРУПА 1

Техника и сравнение

6 грешки · Написано → Правилно → Защо

№	НАПИСАНО	ПРАВИЛНО	ЗАЩО
01	Полето „Техника“ е оставено празно.	«КТ на главния мозък без контраст; аксиалните срезове са оценени в мозъчен и костен прозорец.»	*Без да знае кое изследване и при какви условия е оценено, читателят не може да прецени тежестта на находките.*
02	«КТ на корема с IV контраст.»	«КТ на корема и малкия таз с IV контраст, портално-венозна фаза.»	*Фазата определя дали една находка ще се види; без информация за артериалната фаза не може да се тълкува активно кървене.*
03	Не е записана техническа недостатъчност (артефакт от движение, недостатъчно вдишване).	«Поради артефакт от движение оценката на задната черепна ямка е ограничена.»	*Ако ограничението не е записано, изречението „без находка“ се чете като по-надеждно, отколкото е в действителност.*
04	«Сравнено с предходното изследване.»	«[Дата]: сравнено с КТ на гръден кош от посочената дата.»	*Без дата и модалност не може да се провери с кое изследване е сравнено.*
05	Има предходно изследване, но не е направено сравнение.	«В сравнение с предходното изследване размерът на възела се е увеличил от [.. mm] до [.. mm].»	*Основният въпрос при контролното изследване често е промяната; без сравнение описанието не отговаря на въпроса.*
06	«Сравнение: няма.»	«Няма предходно изследване за сравнение.»	*«Няма» е неясно: няма го в системата или не е оглеждано? Ясното изречение премахва този въпрос.*

ГРУПА 2

Терминология

7 грешки · Написано → Правилно → Защо

№	НАПИСАНО	ПРАВИЛНО	ЗАЩО
07	При КТ „хиперинтензна лезия“.	При КТ „хиперденсна лезия“.	*При КТ се използва плътност, при ЯМР — сигнал, при ехография — ехогенност; грешният термин създава впечатлението, че не познавате модалността.*
08	При ехография „хиподенсна формация“.	При ехография „хипоехогенна формация“.	*Ехогенността е термин, специфичен за ехографията.*
09	При киста — „хипоехогенна“.	При проста киста — „анехогенна“.	*Анехогенен и хипоехогенен означават различно съдържание; диагнозата проста киста се основава на тази разлика.*
10	«Наблюдава се тумор.»	«[.. mm] обемна лезия.»	*Туморът е хистологична диагноза; образната находка се описва като формация или лезия.*
11	«Инфилтрация» (за всяко засенчване на рентгенографията).	Описателен термин като «консолидация», «матово стъкло», «ретикуларно засенчване».	*«Инфилтрация» е неясно и означава различни неща за различните лекари.*
12	«Има обемен ефект.»	«Изличаване на браздите, компресия на ипсилатералния вентрикул и [.. mm] изместване на средната линия.»	*Степента на обемния ефект трябва да се даде с размер и находки; клиничното решение зависи от това.*
13	«В нормални граници» (за всичко).	Запишете накратко съответните органи един по един: «Черният дроб, слезката и бъбреците са с нормален вид.»	*Остава неясно какво е оценено; читателят не може да забележи пропуснатия орган.*

ГРУПА 3

Локализация, страна и размер

8 грешки · Написано → Правилно → Защо

№	НАПИСАНО	ПРАВИЛНО	ЗАЩО
14	Не е посочена страна: „Плеврален излив.“	«Плеврален излив вдясно.»	*Липсата на страна може да доведе до сериозна грешка при интервенции като торакоцентеза или операция.*
15	Грешна страна, останала от шаблона.	Страната се проверява втори път по маркера върху образа и по направлението.	*Това е най-опасната от грешките при копиране и поставяне; страната в „Находки“ и „Заключение“ трябва да е една и съща.*
16	«Лезия в левия бял дроб.»	«Лезия в горния сегмент на левия долен лоб.»	*Информацията за лоб и сегмент е необходима както при проследяването, така и при планирането на бронхоскопия или биопсия.*
17	«Голяма формация», «малък възел».	«[.. x .. mm] формация», «[.. mm] възел».	*Прилагателните не са размер; промяната при проследяване може да се оцени само с числа.*
18	Измерен е само един размер, равнината не е посочена.	«В аксиална равнина [.. x .. mm], краниокаудално [.. mm].»	*Измерване в различна равнина създава при проследяването погрешно впечатление за нарастване или намаляване.*
19	Липсва мерна единица: «Възел 8.»	«Възел [.. mm].»	*Число без мерна единица може да бъде разчетено погрешно и е медико-юридически незащитимо.*
20	При чернодробна лезия — „в десния лоб“.	«Сегмент [..]».	*Информацията за сегмента е стандарт при хирургичното и интервенционалното планиране.*
21	При фрактура на ребро липсва номер.	«Вдясно [..]. ребро – фрактура в латералната дъга.»	*Кое ребро е счупено е необходимо за проследяването и за съпоставяне с клиничния преглед.*

ГРУПА 4

Находки

9 грешки · Написано → Правилно → Защо

№	НАПИСАНО	ПРАВИЛНО	ЗАЩО
22	Спряно е при първата находка; втората находка е пропусната.	Всяка област се преглежда всеки път в един и същ ред; записва се и втората находка.	*«Спиране при първата находка» (satisfaction of search) е най-честата причина за пропуск.*
23	Не е записана важна отрицателна находка (при въпрос за апендицит не се споменава апендиксът).	«Апендиксът е с нормален вид; не се установяват белези на остър апендицит.»	*Ако органът, за който е клиничният въпрос, не е споменат, клиницистът не може да знае дали е оценен.*
24	При въпрос за кръвоизлив не се споменава костният прозорец.	«В костен прозорец не се установява фрактура на калвариума.»	*Оценката на фрактури при КТ за травма изисква костен прозорец; ако не е записано, се приема, че не е оглеждан.*
25	Находките са смесени с тълкуване: „Наблюдава се пневмония.“	В „Находки“: „Консолидация с въздушна бронхограма.“ В „Заключение“: „Може да съответства на пневмония.“	*„Находки“ съдържа наблюдението, „Заключение“ — тълкуването; когато двете се смесят, описанието трудно може да бъде защитено.*
26	Не се споменават тръбите и катетрите.	«Върхът на ЕТТ е на **[.. cm]** над карината; върхът на ЦВК е в проекция на горната празна вена.»	*Най-честият клиничен въпрос при рентгенографиите в интензивното отделение е позицията на устройствата.*
27	Пропуснати са други структури в зрителното поле (горен корем при КТ на гръден кош).	«В изобразените срезове на горния корем: **[не се установява патология/..]**.»	*Всяка структура в зрителното поле е отговорност на описващия; лезии на надбъбреците или черния дроб често се пропускат.*
28	Една и съща находка е повторена три пъти в „Находки“.	Всяка находка се записва веднъж, под съответния орган.	*Повторението удължава описанието и затруднява читателя да открие основната находка.*
29	Костната лезия не е описана: „Лезия в костта.“	«**[Кост]**: **[.. mm]**, **[литична/склеротична]**, **[мясна/широка]** преходна зона на лезията; периостална реакция **[няма/има]**.»	*Характерът на костната лезия (преходна зона, матрикс, периост) определя диференциалната диагноза.*
30	За течна колекция не са дадени съдържание и размер.	«**[.. x .. mm]**, периферно контрастираща се колекция; газ в нея: **[няма/има]**.»	*Решението за дренаж се взема според размера, съдържанието и характеристиките на стената.*

ГРУПА 5

Заключение

8 грешки · Написано → Правилно → Защо

№	НАПИСАНО	ПРАВИЛНО	ЗАЩО
31	Заключението е копие на „Находки“.	В „Заключение“ — само значимите находки и тяхното тълкуване, подредени по важност.	*Разделът „Заключение“ е обобщение и тълкуване на находките; копието показва, че не е направено тълкуване.*
32	Заключението не отговаря на клиничния въпрос.	Първото изречение отговаря на клиничния въпрос: «Не се установяват белези на остър апендицит.»	*Лекарят, написал направлението, търси отговора на въпроса си в първото изречение.*
33	Инцидентална находка е на първо място, спешната — накрая.	Спешната находка винаги е на първо място; инцидентните находки — най-накрая.	*Читателят често чете само първия ред.*
34	«Препоръчва се корелация с клиниката» (във всяко описание, без обосновка).	Напишете с какво и защо да се корелира: „Препоръчва се корелация с лабораторните маркери за инфекция.“	*Препоръка за корелация без обосновка не носи информация и намалява надеждността на описанието.*
35	Дълъг и уклончив списък с диференциални диагнози.	Първо най-вероятната диагноза, след това най-много две-три реалистични диференциални диагнози.	*Списък от десет точки не насочва клинициста; насочва го подредбата по вероятност.*
36	«Малигненост не може да се изключи» (без обосновка).	Запишете находките в полза или против малигненост и препоръчаната следваща стъпка.	*Необосновано „не може да се изключи“ създава ненужна тревога и верига от изследвания.*
37	Неясна степен на сигурност: „Пневмония?“	«Съответства на пневмония» / «в полза на пневмония» / «може да е пневмония» — изберете коя от тях е.	*Въпросителният знак не е език на описанието; степента на сигурност се изразява със стандартни формулировки.*
38	Промяната спрямо предходното изследване липсва в „Заключение“.	«В сравнение с предходното изследване [8 .. лезия] – регресия.»	*При контролно изследване клиничното решение се взема според промяната.*

ГРУПА 6

Препоръка

4 грешки · Написано → Правилно → Защо

№	НАПИСАНО	ПРАВИЛНО	ЗАЩО
39	«Препоръчва се допълнително изследване.»	«За характеризиране се препоръчва ЯМР на главния мозък с контраст.»	*Ако не е написано кое изследване и защо, препоръката не може да бъде изпълнена.*
40	Към всяка находка е добавена препоръка за проследяване.	Конкретна препоръка само за находки, които ще променят клиничното решение.	*Ненужната препоръка означава ненужно изследване, разходи и тревога за пациента.*
41	Записан е интервал на проследяване, в който няма сигурност.	«Необходимостта от проследяване се определя съвместно с клиничния екип според актуалните препоръки.» — или попитайте Вашия ръководител.	*Грешният интервал може да навреди на пациента; ако не сте сигурни в числото, не го пишете.*
42	Записана е препоръка за лечение: „Трябва да се започне антибиотик.“	«Може да съответства на пневмония.»	*Решението за лечение е на клиничния екип; рентгенологичното описание дава диагностична информация.*

ГРУПА 7

Спешна находка и съобщаване

4 грешки · Написано → Правилно → Защо

№	НАПИСАНО	ПРАВИЛНО	ЗАЩО
43	Спешната находка е в описанието, но не е съобщена.	Съобщете по телефона и документирайте в описанието: «Клиничен екип: [час] — съобщено.»	*Времето до прочитането на описанието може да е критично за пациента.*
44	Съобщено е, но липсва в описанието.	«[Час] ч., [отделение]: съобщено по телефона на дежурния лекар.»	*Незаписаното съобщаване може медико-юридически да се счита за ненаправено.*
45	Запис за съобщаването: „казано на лекаря“.	На кого (длъжност и отделение), в колко часа, по какъв начин и дали е направено обратно прочитане.	*Неясният запис прави невъзможна проверката на съобщаването.*
46	Спешната находка е в средата на заключението.	Спешната находка е първото изречение на заключението.	*Клиницистът, който чете бързо, може да спре на първия ред.*

ГРУПА 8

Форма и преди подписване

4 грешки · Написано → Правилно → Защо

№	НАПИСАНО	ПРАВИЛНО	ЗАЩО
47	В описанието са останали квадратни скоби или текст от шаблона.	Преди подписване знаците [ ] и «...» се търсят и изтриват.	*Останалият текст от шаблона показва, че описанието е изпратено, без да е прочетено.*
48	Несъответствие в името на пациента, датата на изследването или направлението.	Самоличността на пациента, датата и видът на изследването се сверяват с описанието.	*Описание на грешен пациент е сред най-сериозните грешки при описването.*
49	Използвани са съкращения без обяснение (неутвърдени).	Неутвърдено съкращение изписвайте изцяло при първата употреба.	*Описанието се пише не само за рентгенолозите, а за всички клиницисти.*
50	Грешка при диктовка или изписване: „ляво“ вместо „дясно“, „хипо“ вместо „хипер“.	Преди подписване прочетете описанието веднъж от началото до края.	*Грешка в една буква може да обърне смисъла на находката.*

С образователна цел. Този материал не заменя обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Сега отворете Бонус 3 · Описание според клиничния въпрос: 30 клинични въпроса. Голяма част от грешките произтичат от това, че описанието не отговаря на клиничния въпрос; вижте на какво задължително трябва да отговори описанието при 30-те най-чести въпроса.

За правилните формули на изреченията можете да се върнете към **Бонус 1 · Банка от 200 заключения на описанието**.